

MODULE URGENCES MÉDICALES

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles. Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules, ni la pratique en classe.

Pour chaque urgence médicale, la démarche est la même : SEP complet, questionnaire SAMPLE en premier puisque la victime est malade et non blessée, signes vitaux en série, puis la question qui guide tout : quel type de choc cette urgence peut-elle produire, et faut-il évacuer ?

CONTENU DU MODULE — ONZE LEÇONS

INTRODUCTION

00 Introduction au chapitre

SYSTÈMES VITAUX

01 Urgences cardiovasculaires

02 Urgences cérébrovasculaires

03 Urgences respiratoires

NEUROLOGIQUE ET MÉTABOLIQUE

04 Épilepsie et convulsions

05 Diabète

SYSTÈME DIGESTIF

06 Urgences abdominales aiguës

07 Gastroentérite

RÉACTIONS ET SUBSTANCES

08 Réactions allergiques et anaphylaxie

09 Poisons et toxines

10 Médicaments

00

Introduction au chapitre

Dix leçons, regroupées en quatre familles, pour reconnaître ce qui se passe à l'intérieur

Une urgence médicale n'a pas de mécanisme de blessure visible. C'est le questionnaire, les antécédents et l'évolution des signes vitaux qui vous disent ce qui se passe, et le type de choc qui menace.

- 1 Quatre familles pour organiser votre raisonnement.** Systèmes vitaux (cœur, cerveau, poumons), neurologique et métabolique (épilepsie, diabète), système digestif (abdomen aigu, gastroentérite), réactions et substances (allergies, poisons, médicaments).
- 2 Malade : le questionnaire médical d'abord.** SAMPLE avant l'examen physique. Les symptômes rapportés par la victime sont vos données subjectives ; ce que vous mesurez et observez sont vos données objectives. Notez les deux, et les écarts.
- 3 Toujours vous demander : quel choc ?** Chaque urgence de ce module peut évoluer vers un type de choc précis (cardiogénique, hypovolémique, distributif, respiratoire). Le reconnaître tôt oriente la position, la surveillance et l'urgence de l'évacuation.
- 4 Le manuel terrain contient un SAMPLE par urgence.** Utilisez-le comme guide de questionnement pendant l'évaluation, pas seulement comme référence après coup.
- 5 Les médicaments : savoir qu'ils existent, à quoi ils servent, et vos limites.** Le secouriste aide la victime à prendre sa propre médication prescrite. Il ne prescrit pas. Les exceptions sont vues en classe, cas par cas, dans les scénarios.

01

Urgences cardiovasculaires

Reconnaître la douleur thoracique et les signes d'atteinte du cœur

Angine, crise cardiaque, arrêt cardiaque : un même continuum. L'angine est un apport insuffisant de sang oxygéné au cœur ; l'infarctus, une nécrose du muscle ; l'arrêt, l'incapacité du cœur à se contracter. Le choc associé est cardiogénique.

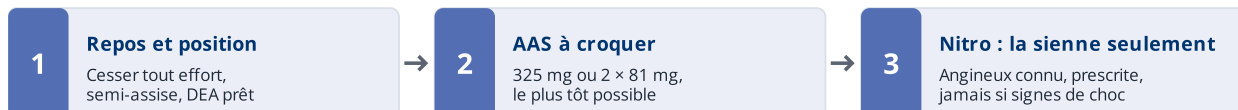


Figure 1 — L'ordre compte : l'AAS améliore la survie, la nitroglycérine soulage seulement.

- 1 **Les signes qui doivent vous alerter.** Pesanteur, serrement ou pression au thorax de 2 à 15 minutes, irradiant au bras gauche, au dos, à la mâchoire ou aux deux bras, avec nausée, sudation excessive, faiblesse, souffle court et souvent déni. Les femmes, les personnes âgées et diabétiques présentent parfois des tableaux atypiques.
- 2 **Angine ou infarctus : le repos tranche.** L'angine se soulage au repos et avec la médication prescrite. Une douleur qui persiste malgré le repos, qui revient vite ou qui s'accompagne de signes de choc évoque l'infarctus : activez les secours ou l'évacuation sans attendre.
- 3 **L'AAS d'abord, le plus tôt possible.** L'aspirine est le seul médicament dont on a démontré qu'il améliore la survie en cas d'infarctus. Aidez la victime à croquer 325 mg (ou 2 comprimés de 81 mg), sauf allergie ou contre-indication connue. En région isolée, avec des délais importants, la recommander est raisonnable : très faible risque, bénéfice élevé.
- 4 **La nitroglycérine : seulement à la victime qui a la sienne.** Elle n'améliore pas la survie et peut provoquer une hypotension importante. Réservée aux personnes connues angineuses qui ont leur prescription et savent l'utiliser : jamais en présence de signes de choc ni après un vasodilatateur (Viagra, Cialis, Levitra) dans les 48 heures.
- 5 **Repos strict, position, surveillance, DEA prêt.** Cessez toute activité, position semi-assise ou de confort, oxygène si disponible, signes vitaux en série. Si la victime perd conscience et ne respire pas : RCR et DEA. Urgence hypertensive : tension à 180/120 ou plus avec symptômes.

02

Urgences cérébrovasculaires

Repérer rapidement les signes d'un AVC et agir sur le temps

L'AVC est une interruption de la circulation vers une partie du cerveau, par blocage (ischémique) ou par rupture d'un vaisseau (hémorragique). L'AIT donne les mêmes signes, mais ils disparaissent en moins de 24 heures : c'est un avertissement, pas une fausse alerte.

- 1 Tout ce qui est soudain est suspect.** Faiblesse ou engourdissement subit du visage ou d'un membre, trouble d'élocution, trouble de vision, perte d'équilibre, céphalée brutale et inhabituelle, étourdissements, altération de la conscience.
- 2 VITE : le dépistage en trois gestes.** Visage : demandez un sourire, cherchez l'asymétrie. Inertie : demandez de lever les deux bras, l'un dérive ou ne monte pas. Trouble d'élocution : faites répéter une phrase simple. Extrême urgence : un seul signe suffit pour agir.
- 3 Chaque minute compte, vraiment.** Le traitement hospitalier est le plus efficace dans les premières heures après le début des symptômes. Notez l'heure exacte du début (ou la dernière fois vue normale) : c'est l'information la plus importante à transmettre.
- 4 Pas d'aspirine.** Contrairement à la crise cardiaque, vous ne pouvez pas distinguer sur le terrain un AVC ischémique d'un AVC hémorragique. L'AAS aggraverait une hémorragie cérébrale.
- 5 Position, voies respiratoires, évacuation.** Position confortable, latérale de sécurité si altération de la conscience ou vomissements, rien par la bouche (trouble de déglutition fréquent), oxygène si disponible, préparez-vous à la RCR. Facteurs de risque à connaître : hypertension, diabète, tabac, AVC ou AIT antérieur.

03

Urgences respiratoires

Distinguer les causes de détresse respiratoire et soutenir la victime

La détresse respiratoire est une menace directe sur l'oxygène, le premier des sept éléments essentiels. Le choc associé est respiratoire ou obstructif. L'asthme en est la cause médicale la plus fréquente en région isolée.

- 1 **Reconnaître une respiration inefficace.** Fréquence rapide ou très lente, effort visible, muscles accessoires, lèvres pincées, phrases incomplètes, sifflement à l'expiration, cyanose, agitation puis somnolence. Une victime qui se calme sans s'améliorer est en train de s'épuiser : c'est un signe de gravité.
- 2 **L'asthme : inflammation, mucus, spasme.** Les bronches s'enflamment, sécrètent du mucus et se contractent. Déclencheurs fréquents : effort, froid, allergènes, infection respiratoire, fumée, stress. L'expiration devient longue et sifflante, le thorax se distend.
- 3 **La médication de la victime, tout de suite.** Aidez-la à prendre son bronchodilatateur de secours (pompe bleue, type salbutamol) selon sa prescription ; il agit en quelques minutes. Les corticostéroïdes inhalés sont un traitement de fond, pas un médicament de crise.
- 4 **Position et calme.** Assise, penchée vers l'avant, bras appuyés. Rassurez, faites respirer lentement, éloignez du déclencheur, réchauffez l'air inspiré au froid. Signes vitaux en série, en particulier la fréquence respiratoire et la capacité à parler.
- 5 **Évacuer si la pompe ne suffit pas.** Absence d'amélioration après la médication, besoin répété de doses, cyanose, incapacité de parler, altération de la conscience : évacuation urgente. Considérez aussi les autres causes de dyspnée : anaphylaxie, pneumonie, pneumothorax, embolie, hyperventilation anxieuse.

04

Épilepsie et convulsions

Protéger la victime pendant la crise, savoir quoi observer

On peut convulser sans être épileptique. L'épilepsie est une condition chronique ; la crise épileptique, une décharge électrique anormale ; la convulsion, ses contractions musculaires. Fièvre, hypoglycémie, traumatisme crânien, intoxication et manque de sommeil peuvent tous provoquer une crise.

- 1 Partielle ou généralisée.** La crise partielle touche une fonction précise (motrice, sensorielle, comportement) avec ou sans altération de la conscience. La crise tonico-clonique généralisée passe par une phase rigide puis des secousses, dure en général moins de 2 minutes, avec parfois incontinence et arrêt bref de la respiration.
- 2 Pendant la crise : protéger, chronométrer, ne rien forcer.** Éloignez les objets dangereux, protégez la tête, ne retenez pas la personne, ne mettez rien dans la bouche. Notez l'heure de début et la durée : c'est votre donnée la plus utile.
- 3 Après la crise : la phase post-ictale.** Confusion, fatigue, désorientation pendant quelques minutes à quelques heures. Position latérale de sécurité, voies respiratoires dégagées (ronflement fréquent), surveillance de la respiration et de la conscience, réchauffement, retour progressif.
- 4 Les signaux d'évacuation urgente.** Crise de plus de 5 minutes ou crises répétées sans reprise de conscience entre elles (état de mal épileptique), première crise de sa vie, crise après un traumatisme crânien, blessure pendant la crise, grossesse, diabète, ou non-retour à la normale.
- 5 Avant le départ : connaître les personnes à risque.** Type de crise, facteurs déclenchants, fréquence, médication et effets secondaires, plan personnel. La crise fébrile de l'enfant (6 mois à 6 ans) se prend en charge par la surveillance ABC et le contrôle de la fièvre.

05

Diabète

Reconnaître les variations de glycémie et leurs signes trompeurs

Le glucose a besoin de la clé insuline pour entrer dans la cellule. Type 1 : le pancréas ne produit plus d'insuline. Type 2 : il n'en produit pas assez ou elle agit mal. Les deux urgences sont l'hypoglycémie (rapide, dangereuse) et l'hyperglycémie (lente, grave).

- 1 **L'hypoglycémie ressemble à tout sauf au diabète.** Apparition rapide : faim, tremblements, sueurs, peau pâle, froide et moite, pouls rapide, céphalée, confusion, agitation, trouble d'élocution, comportement étrange, convulsions, perte de conscience. Elle imite l'ivresse, l'AVC ou le traumatisme crânien.
- 2 **L'hyperglycémie s'installe sur des heures ou des jours.** Soif intense, urines abondantes, faiblesse, nausées, vomissements, haleine fruitée (acétone), peau chaude et sèche, respiration profonde et rapide, déshydratation, puis altération de la conscience. Le traitement est médical : hydratation et évacuation.
- 3 **Dans le doute, donnez du sucre.** Un sucre simple améliore l'hypoglycémie en quelques minutes et ne change presque rien à l'hyperglycémie. Victime consciente : sucre simple, puis un repas complet si elle s'améliore. Victime inconsciente : position latérale de sécurité, gel de glucose frotté à l'intérieur de la joue, évacuation.
- 4 **Le glucomètre confirme, il ne remplace pas la clinique.** S'il est disponible et que la victime ou un proche sait l'utiliser, mesurez avant et après. Notez les valeurs et l'heure sur la fiche SEP.
- 5 **Le glucagon nasal (Baqsimi) fait partie du plan de la victime, pas de votre trousse.** Une personne diabétique de type 1 en expédition devrait l'avoir et vous avoir montré son plan de gestion avant le départ. La rencontre préparatoire et le formulaire médical servent à cela.

06

Urgences abdominales aiguës

Évaluer une douleur abdominale et reconnaître les signes de gravité

L'abdomen aigu est une douleur abdominale sévère d'apparition soudaine. Infection (appendicite, péritonite), obstruction, perforation ou hémorragie interne : sur le terrain, vous ne pourrez pas trancher. Votre travail est de reconnaître la gravité et de décider de l'évacuation.

- 1 **Caractériser la douleur avec SAMPLE et OPQRST.** Début, localisation, migration, type (crampe, brûlure, lancinante), intensité, ce qui l'aggrave ou la soulage, symptômes associés. Une douleur diffuse qui se localise ensuite est un tableau classique d'appendicite.
- 2 **Les signaux d'alarme qui imposent l'évacuation.** Sang dans les vomissements, les selles (noires ou rouges) ou l'urine ; fièvre avec vomissements ; ventre rigide, distendu ou défense à la palpation ; douleur qui empêche de bouger ou de marcher ; signes de choc ; absence de bruits intestinaux ; hernie.
- 3 **Tous les cas d'abdomen aigu sont évacués.** En cas de doute, initiez l'évacuation. Le risque de complication est élevé et le délai en région isolée se compte en heures. Une douleur abdominale qui dure plus de quelques heures sans diagnostic évident ne s'attend pas.
- 4 **Position de confort, à jeun, ne marche pas.** Le plus souvent semi-assise ou sur le côté, genoux fléchis, pour relâcher la paroi. Rien de solide par la bouche ; petites gorgées de liquides clairs si l'évacuation se prolonge. Transport en civière.
- 5 **Surveiller, traiter le choc, documenter.** Signes vitaux en série, palpation répétée par la même personne, notez toute évolution. Le choc peut être hypovolémique (hémorragie interne, vomissements) ou septique (infection).

07

Gastroentérite

Gérer la déshydratation et limiter la transmission au sein du groupe

Une infection de l'estomac et des intestins par des virus, bactéries ou parasites, transmise le plus souvent par contamination fécale de l'eau, des aliments et des mains. En expédition, son vrai danger est double : la déshydratation et la contagion du groupe.

- 1 Le tableau habituel.** Nausées, vomissements, diarrhée, crampes, parfois fièvre et courbatures. Le choc associé est hypovolémique : perte de liquides et d'électrolytes. Un enfant peut perdre 10 à 20 % de son volume circulant en moins de deux heures.
- 2 La réhydratation est le traitement.** Petites quantités fréquentes plutôt que de grands volumes. Solution de réhydratation orale de préférence, sinon eau avec un peu de sucre et de sel, bouillon. Reprise alimentaire légère dès que tolérée. Surveillez la couleur et la quantité des urines.
- 3 Les signaux d'alarme.** Incapacité de garder les liquides, sang dans les selles, fièvre élevée, douleur abdominale localisée ou rigide, signes de déshydratation sévère (pouls rapide, étourdissements en se levant, peu d'urine, confusion), symptômes qui durent plus de quelques jours.
- 4 Protéger le reste du groupe.** Lavage des mains rigoureux, préparation des aliments par une personne non atteinte, vaisselle et gourdes individuelles, désinfection de l'eau, gestion des selles loin des sources d'eau, isolement relatif de la personne malade.
- 5 Lopéramide et antibiotiques : introduction seulement.** Le lopéramide (Imodium) ralentit le transit et peut aider en déplacement, mais il est déconseillé en présence de fièvre ou de sang dans les selles. Les antibiotiques relèvent d'une décision médicale ou d'un protocole d'expédition, pas du secouriste seul.

08

Réactions allergiques et anaphylaxie

Reconnaître l'anaphylaxie et intervenir sans délai

L'histamine explique tout. Libérée localement, elle donne rougeur, démangeaison et enflure. Libérée massivement, elle dilate les vaisseaux, fait fuir le plasma et resserre les bronches : c'est l'anaphylaxie et son choc distributif.

- 1 Réactions locales : incommodes, rarement dangereuses.** Rhinite, urticaire localisée, eczéma de contact (herbe à puce, sumac), réaction locale à une piqûre. Prise en charge : retirer l'allergène, laver, froid local, antihistaminique. Surveillez l'évolution : une réaction locale peut annoncer une réaction généralisée.
- 2 Reconnaître l'anaphylaxie.** Détresse respiratoire sévère ou défaillance circulatoire, OU au moins deux des quatre tableaux suivants : urticaire ou angioedème (lèvres, langue, paupières), difficulté respiratoire, signes de choc (faiblesse, étourdissement), symptômes digestifs (nausées, vomissements, crampes, diarrhée).
- 3 L'épinéphrine, immédiatement, en intramusculaire.** Auto-injecteur (EpiPen) dans la face externe de la cuisse, à travers le vêtement si nécessaire. Quand la vie est en danger, il n'y a aucune contre-indication. Une deuxième dose peut être nécessaire après 5 à 15 minutes si les signes persistent ou reviennent.
- 4 Ensuite seulement : antihistaminique, position, choc.** Antihistaminique à action rapide (diphenhydramine) si la victime peut avaler, jamais de préparation à libération lente. Position couchée jambes surélevées si choc, assise si difficulté respiratoire. Traitez l'état de choc, gardez au chaud.
- 5 Toujours évacuer, même si tout va mieux.** Les signes peuvent revenir plusieurs heures après (réaction biphasique). Surveillance étroite pendant 24 heures et évacuation vers un établissement médical. Sachez avant le départ qui a une allergie et où est son auto-injecteur.

09

Poisons et toxines

Identifier l'exposition, limiter l'absorption, orienter la prise en charge

Trois voies d'entrée, trois logiques de prise en charge. Ingestion : empêcher l'absorption. Inhalation : sortir de l'atmosphère toxique. Contact cutané : retirer et rincer. Dans tous les cas, le centre antipoison est votre allié à distance.

LES 16 RUBRIQUES

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

En couleur : les cinq rubriques utiles au secouriste.

- 1 Identification.** Nom exact du produit et coordonnées du fournisseur : c'est ce que le centre antipoison demande en premier.
- 2 Identification des dangers.** Pictogrammes, mention d'avertissement et conseils de prudence : ce à quoi vous avez affaire, en un regard.
- 4 Premiers soins.** Mesures d'urgence par voie d'exposition : inhalation, contact cutané ou oculaire, ingestion. La rubrique à lire en premier.
- 6 Déversement accidentel.** Précautions individuelles avant d'approcher, et méthode de nettoyage.
- 8 Contrôle de l'exposition.** Équipement de protection individuelle requis : gants, écran facial, protection respiratoire.

Figure 2 — Fiche de données de sécurité (FDS, SIMDUT et SGH) : ordre normalisé des 16 rubriques. Les autres (3, 5, 7 et 9 à 16) relèvent de la prévention, du transport et de la réglementation, pas de l'intervention.

- 1 Ingestion : identifier, appeler, ne pas faire vomir.** Quoi, combien, quand, chez qui. Gardez le contenant ou l'échantillon. Ne provoquez pas de vomissements. Contactez le centre antipoison dès qu'une communication est possible et évacuez.
- 2 Le charbon activé n'est pas un outil préhospitalier.** Il fixe le poison dans le tube digestif avant son absorption, mais son administration relève du milieu hospitalier : elle suppose une évaluation médicale, des voies respiratoires protégées, et des doses (adulte 50 à 100 g) qui ne correspondent pas aux formats vendus en pharmacie. Il est de toute façon inutile ou contre-indiqué avec les acides et bases forts, les métaux, l'alcool et les hydrocarbures, et chez une victime somnolente. Sur le terrain : identifiez le produit, joignez le centre antipoison, évacuez.
- 3 Le monoxyde de carbone : le tueur invisible des abris.** Incolore, inodore, produit par toute combustion en espace clos (réchaud sous la tente, abri de neige, chalet mal ventilé). Céphalée, nausées, étourdissements, faiblesse, confusion, souvent chez plusieurs personnes à la fois. Sortez tout le monde à l'air libre, oxygène si disponible, évacuez.
- 4 Contact cutané : retirer, rincer longtemps.** Enlevez les vêtements contaminés avec des gants, brossez les poudres sèches avant de mouiller, rincez abondamment à l'eau. Protégez-vous en premier.
- 5 Prévenir : connaître ce que le groupe transporte et ce que le milieu contient.** Médicaments, carburants, produits de désinfection de l'eau ; plantes, champignons, insectes, serpents de la région. Le plan d'urgence devrait contenir le numéro du centre antipoison de la région visitée.

10

Médicaments

Connaître votre marge d'action et vos limites de secouriste

Le secouriste n'est pas un prescripteur. Cette leçon vous apprend ce qui existe, à quoi cela sert et dans quel cadre vous pouvez aider une victime à prendre un médicament. Toute prise de médicament devrait être supervisée par un médecin ou encadrée par un protocole.

- 1 Trois situations distinctes.** Aider la victime à prendre sa propre médication prescrite (nitro, pompe, auto-injecteur) ; lui recommander un médicament en vente libre qu'elle décide de prendre (AAS, antihistaminique, analgésique) ; administrer un médicament d'urgence sous protocole ou avis médical. Votre rôle change à chaque niveau.
- 2 Les médicaments rencontrés dans ce module.** AAS pour l'infarctus suspecté, nitroglycérine (la sienne, angineux connu), bronchodilatateur de secours, épinéphrine, antihistaminiques, gel de glucose, glucagon nasal, charbon activé, solution de réhydratation, lopéramide. Sachez leur indication, leur forme et leur limite.
- 3 Les cinq vérifications avant d'aider.** La bonne personne, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie, le bon moment. Vérifiez les allergies, les contre-indications connues et ce qui a déjà été pris (le M et le A du SAMPLE).
- 4 Documenter, toujours.** Nom, dose, heure, voie, effet observé et effets secondaires, sur la fiche SEP. C'est l'information que les services médicaux vous demanderont en premier.
- 5 Prise de décision en scénario.** En classe, chaque mise en situation vous fera décider si un médicament est pertinent, lequel, et par qui. La règle générale demeure : dans le doute, la téléconsultation ou l'évacuation prime sur l'improvisation.